

결정하기 전, 이것만 확인하세요

Q1 O자 다리면 모두 수술하나요?

아닙니다. 통증·기능 제한과 체중 부하 X-ray, 관절염 범위, 인대 안정성을 함께 봅니다.

Q2 인공관절 대신 받을 수 있나요?

내측에 국한된 관절염과 O자 정렬이 있는 일부 환자에서 관절 보존 치료로 검토합니다.

Q3 수술 뒤 바로 걷나요?

목발·보조기를 사용하며 X-ray의 뼈 유합과 진찰 결과에 따라 체중 부하를 단계적으로 늘립니다.

수술 뒤 바로 알려야 할 신호

- 상처의 심한 열감·붉어짐·분비물 또는 계속되는 발열
- 종아리의 갑작스러운 붓기·통증, 숨참이나 흉통

수술 권유를 받았더라도 다시 확인할 수 있습니다

증상과 체중 부하 무릎·하지 전장 X-ray를 함께 보고 관절염 분포, 다리 정렬과 치료 선택지를 설명합니다.



김동희 원장

정형외과 전문의 · 무릎 관절

진찰과 영상을 직접 설명하고 비수술 치료부터 절골술·인공관절까지 개인별 치료 범위를 상담합니다.

진료 전에 가져오세요

- 최근 무릎 X-ray·MRI CD와 판독지
- 서서 찍은 하지 전장 정렬 X-ray
- 통증 위치·기간, 치료·수술 이력과 복용 약

대표 전화 031-328-0333

경기도 용인시 처인구 중부대로 1539

진료 일정은 방문 전 대표 전화로 확인해 주세요.

이 자료는 일반적인 환자 교육용입니다. 개인별 치료 계획은 진찰과 검사 결과에 따라 달라집니다.

환자·보호자용 치료 안내

무릎 관절염과 오(O)자 다리

안쪽 무릎 통증과 다리 축 변형이 있다면 관절염의 범위와 체중 부하 정렬을 확인합니다.

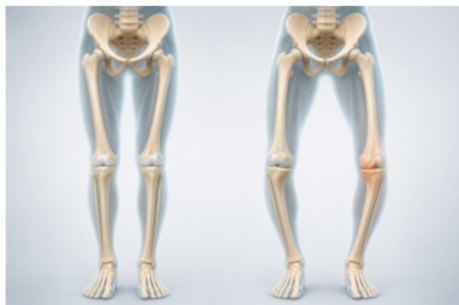


근위 경골 절골술(HTO)

O자 다리를 교정해 체중 부하를 손상된 안쪽에서 비교적 건강한 바깥쪽으로 옮기는 관절 보존 수술입니다.

01 질환·증상

O자 정렬에서는 체중이 무릎 안쪽에 더 집중될 수 있습니다. 내측 연골이 닳으면 통증·붓기·뻣뻣함과 보행 제한이 생깁니다.



중립 정렬

O자 정렬 · 내측 마모

이런 증상을 확인합니다

- 걷기·계단에서 심해지는 무릎 안쪽 통증
- 붓고 뻣뻣하며 움직임이 줄어들
- 다리 축이 휘고 보행 거리·생활 동작이 감소

진단의 핵심

서서 찍는 무릎 X-ray와 하지 전장 정렬 X-ray로 관절 간격과 체중 부하 축을 봅니다. 증상·가동 범위·인대 안정성도 함께 확인합니다.

02 치료 선택

O자 모양만으로 수술하지 않습니다. 통증과 기능, 관절염이 생긴 위치, 정렬·가동 범위·인대 안정성을 함께 봅니다.

먼저 해볼 치료

- 활동 조절·운동·체중 관리와 근력 재활
- 상태에 맞는 약물·주사 치료
- 필요 시 지팡이·보조기와 생활 동작 조정

HTO를 검토할 때

- 비수술 치료 뒤에도 통증과 기능 제한이 지속될 때
- 관절염이 주로 안쪽에 있고 O자 정렬이 동반될 때
- 반대쪽 관절면·가동 범위·인대 안정성이 보존될 때

치료의 흐름

비수술 치료



정렬·관절염
재평가



적합할 때
절골술

03 수술·회복

내측 개방형 근위 경골 절골술



- 가 하지 전장 X-ray로 교정 각도와 체중 부하 축을 계획
- 나 무릎 아래 근위 경골을 절골하고 바깥쪽 뼈 힌지를 보존
- 다 안쪽 간격을 계획만큼 열어 다리 정렬을 교정
- 라 금속판과 나사로 고정하고 정렬·안정성을 확인

회복은 뼈 유합과 기능에 맞춰

- 초기: 상처·부기·통증 관리, 보조기와 목발 사용
- 중기: X-ray를 보며 체중 부하·가동 범위·근력 운동 진행
- 후기: 보행 안정과 직업·운동 기능을 평가해 단계적으로 복귀

알아둘 위험과 한계

감염, 혈전, 신경·혈관 손상, 관절 강직, 지연 유합·불유합, 교정 소실, 금속판 자극, 잔여 통증 등이 있을 수 있습니다. 관절염이 진행하면 이후 인공 관절 수술이 필요할 수 있습니다.